

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

OAS · ESCALA DE AGRESIVIDAD MANIFIESTA

Overt Aggression Scale – Patrón oro para el registro observacional sistemático de incidentes agresivos intrahospitalarios e intervenciones de contención

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Overt Aggression Scale (OAS / Escala de Agresividad Manifiesta)
Autores Originales	Stuart C. Yudofsky, J. M. Silver, W. Jackson, J. Endicott y D. Williams (1986)
Validación Española	Banco de Instrumentos Básicos de Bobes et al. (2004)
Tipo de Instrumento	Registro observacional estructurado por eventos / escala heteroaplicada de enfermería y facultativos
Población Diana	Pacientes psiquiátricos ingresados en unidades de agudos, unidades forenses, centros de discapacidad o residencias
Tiempo de Aplicación	2 a 3 minutos por cada episodio agresivo registrado de forma inmediata
Formato de Respuesta	Clasificación del incidente en 4 categorías jerárquicas de agresividad (4 niveles cada una) y registro de intervenciones
Finalidad Clínica	Monitorización objetiva de conductas agresivas, evaluación de la eficacia de psicofármacos antiimpulsivos y optimización de protocolos de desescalada y seguridad intrahospitalaria

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

En las unidades de hospitalización psiquiátrica y centros sociosanitarios, el registro de la agresividad mediante notas de evolución narrativas convencionales suele ser inconsistente, vago y altamente dependiente del estado emocional del personal de guardia (“paciente muy agitado”, “conducta agresiva”). Esta falta de precisión impide valorar con rigor si un nuevo régimen farmacológico está reduciendo la gravedad o la frecuencia de los incidentes.

Stuart Yudofsky y sus colaboradores en la Universidad de Columbia crearon la OAS como un sistema observacional estandarizado que operacionaliza de forma inequívoca el comportamiento agresivo manifiesto en tiempo real. La escala categoriza la agresión según su vector diana en cuatro modalidades mutuamente excluyentes o concurrentes: verbal, física contra objetos, física contra sí mismo y física contra otros, graduando cada una en 4 niveles ascendentes de daño y riesgo vital, al tiempo que monitoriza las intervenciones terapéuticas desplegadas.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Categoría Agresiva	Niveles	Gradación de Severidad Operacional de las Conductas
1. Agresión Verbal	4 niveles	N1 Insultos leves/gritos; N2 Maldiciones y amenazas veladas; N3 Amenazas explícitas de violencia; N4 Amenazas de muerte graves con intención manifiesta.
2. Contra Objetos	4 niveles	N1 Golpear puertas/muebles; N2 Tirar objetos sin romperlos; N3 Romper cristales o mobiliario; N4 Prender fuego o destrucción sistemática.
3. Contra Sí Mismo	4 niveles	N1 Rascado/golpes sin herida; N2 Cortes superficiales/hematomas; N3 Quemaduras o cortes profundos; N4 Autolesiones con riesgo vital/mutilación.
4. Contra Otras Personas	4 niveles	N1 Gestos amenazantes; N2 Empujones o agarrones; N3 Golpes, puñetazos o patadas leves; N4 Ataque violento que causa lesiones o uso de armas.
Registro de Contención	12 opciones	Medidas adoptadas: diálogo, aislamiento, medicación oral/IM, contención mecánica.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · OAS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Fiabilidad Inter-Jueces	Coefficiente de correlación intraclase ICC = 0.89 a 0.94 entre personal de enfermería y auxiliares psiquiátricos debidamente instruidos (Yudofsky et al., 1986; Bobes et al., 2004).
Validez de Constructo	Excelente validez concurrente con la Staff Observation Aggression Scale (SOAS-R, $r = 0.88$) y con los registros oficiales de contenciones mecánicas de las unidades de agudos.
Sensibilidad al Tratamiento	Detecta con alta sensibilidad la reducción en la tasa de agresiones por paciente/semana inducida por antipsicóticos, anticonvulsivantes y litio.
Estandarización Operativa	Reconocido internacionalmente como el estándar de documentación clínica legal para justificar la necesidad y proporcionalidad de medidas de contención física o farmacológica.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

1. Ponderación de Cada Nivel:

- Para cada una de las 4 categorías, los niveles se puntúan de 1 a 4 puntos según la gravedad observada:
 - Nivel 1 = 1 punto; Nivel 2 = 2 puntos; Nivel 3 = 3 puntos; Nivel 4 = 4 puntos.

2. Cálculo por Episodio: Se registran todas las categorías observadas durante el incidente. Si un paciente grita insultos (Verbal N1 = 1) y acto seguido propina un puñetazo al enfermero (Contra personas N3 = 3), la puntuación del episodio es $1 + 3 = 4$ puntos.

3. Métricas Semanales Acumuladas:

- Frecuencia Total:** Número de incidentes registrados en los últimos 7 días.
- Gravedad Media del Episodio:** Puntos promedio por incidente.
- Puntuación de Agresividad Total Semanal:** Suma de puntos de todos los episodios registrados en la semana.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntos por Episodio	Nivel de Alerta	Riesgo Lesivo	Directriz Asistencial y de Contención
1 a 2 puntos	Agresión Menor	Bajo	Abordaje verbal, desescalada y escucha activa.
3 a 5 puntos	Agresión Moderada	Intermedio	Aislamiento en habitación y medicación oral de rescate.
6 a 8 puntos	Agresión Grave	Elevado	Medicación intramuscular urgente; contención física si precisa.
≥ 9 puntos	Agresión Extrema	Crítico / Vital	Activación de alarma de seguridad, contención mecánica estricta.

VALOR MÉDICO-LEGAL DEL PROTOCOLO OAS: El registro OAS constituye la prueba documental más sólida ante los juzgados de vigilancia y comités de bioética para demostrar que las medidas de contención física o farmacológica aplicadas fueron proporcionadas, justificadas por la gravedad objetiva de la conducta y no arbitrarias.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · OAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Cumplimentación Inmediata tras el Suceso: Registro por el equipo de enfermería que presencié el episodio.

Paso 2: Monitorización Semanal en Sesión Clínica:

- Si predominan agresiones verbales (Categoría 1): intensificar habilidades de comunicación y regular límites ambientales.
- Si se registran agresiones contra objetos o personas (Categorías 2 y 4):
 1. Evaluar si la conducta está motivada por ideación delirante activa (esquizofrenia paranoide) o impulsividad psicopática.
 2. Ajustar pauta antipsicótica o estabilizadora (valproato o clozapina, esta última de elección en agresividad refractaria).
 3. Analizar factores desencadenantes inmediatos (denegación de permisos, consumo de tabaco, provocación entre pacientes).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 25 años ingresado en Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría por descompensación psicótica aguda de inicio reciente. Presenta hostilidad y suspicacia hacia el personal.

Registro OAS del Primer Episodio (Día 2 de ingreso):

- **Agresión Verbal:** Nivel 3 (Amenazas explícitas: "si entran en mi cuarto los voy a destrozar"). Puntuación = 3.
- **Contra Objetos:** Nivel 2 (Tiró la bandeja de la comida contra la pared). Puntuación = 2.
- **Contra Otras Personas:** Nivel 3 (Lanzó un vaso de cristal al auxiliar de enfermería que intentó calmarlo, impactando en el hombro). Puntuación = 3.
- **Puntuación Total del Episodio OAS:** 8 puntos (Agresión Grave).
- **Intervención Registrada:** Reducción verbal fallida; contención física protocolizada por 4 profesionales, administración de medicación intramuscular (olanzapina 10 mg + midazolam 5 mg) y contención mecánica transitoria durante 2 horas.

Seguimiento: El registro estructurado en la OAS justificó legalmente la medida ante el juez de guardia y permitió al equipo médico titular clozapina progresivamente. En la segunda semana de ingreso, los registros en la OAS descendieron a 0 episodios de agresión física, remitiendo la hostilidad paranoide.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS DE SEGURIDAD FÍSICA

- Episodios en la categoría 4 de Nivel 4 (uso de armas o estrangulamiento) exigen evacuación médica de lesionados y denuncia judicial inmediata.
- Toda contención mecánica debe ser prescrita por médico colegiado y revisada como máximo cada 2 horas por enfermería.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Acatisia por Neurolépticos:** Inquietud motora y agitación secundaria al tratamiento que puede confundirse con agresión primaria.
- **Episodio Ictal / Estado Postcrítico:** Agresividad confusional automática tras crisis epiléptica del lóbulo temporal.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Yudofsky, S. C., Silver, J. M., Jackson, W., Endicott, J., & Williams, D. (1986). The Overt Aggression Scale for the objective rating of verbal and physical aggression. *American Journal of Psychiatry*, 143(1), 35–39.
- Silver, J. M., & Yudofsky, S. C. (1991). The Overt Aggression Scale: Overview and clinical application. *Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences*, 3(2), S22–S29.
- Palmstierna, T., & Wistedt, B. (1987). Staff observation aggression scale, SOAS: Presentation and evaluation. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 76(6), 657–663.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.